EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 83689
SERVICIO : MEL HOMBRES HSC
FECHA : 2024-05-02 12:48:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: OCTAVIO ANTONIO FUENTES LOPEZ			RUN	: 4.422.892-0
F.Nac	: 27-02-1939	Edad	: 85 AÑOS, 2 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: COLVINDO			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-05-01	Fecha Egreso	: 2024-05-02 12:48:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N17.9-INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) PNAg BLEE (+) en tratamiento
2) DHC por OH
3) Limitacion severa ABVD
4) Enf de alzheimer
5) Usuario de cistostomia

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec descritos, consulta el 30/04 por cuadro de orina piuricaCEG, fiebre y desorientacion. Se solicitan examenes de lab al ingreso, donde destaca GB 8,8; Hb/Hcto 12.6/37.2; plaq 209000; segment 79%; orina de aspecto turbio, nitritos (+), 500 leu/uL; crea 2,4; PCR 160,3; uremia 122; Na/K/Cl 139/4.3/104. Se decide ingreso apra terapia ATB de primera linea
Paciente estable dentro de su condicion, desorientado durante su estadia, con necesidad de contencion fisica, sin peak febril registrado
Examenes de lab -> crea 2,1 (prev 2,4), PCR 172; Na/K/Cl 140/3.7/104; Gb 7; Hb/Hcto 11.8/35.3; plaq 247000; segment 66%; proca 0,28
URC con desarrollo de proteus mirabilis sensible a imipenem, ertapenem, piperacilina/Tazobactam
Ex fisico -> Vigil, desorientado, no sigue ordenes verbales, mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Abdomen BDI; RHA (+), sin megalias, sin signos de irritacion peritoneal
Extremidades sin edema, sin signos de TVP

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, sin conflicto
3) Infeccioso: URC con desarrollo de proteus mirabilis, multiresistente, se procedera a ajuste de terapia ATB con carbapenemico, se continuara hospitalizacion via HODOm, se solicitara control con examenes dentro de 24 hrs

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentado 30°
2. Regimen papilla espesa asistida
3. Ertapenem 500 mg al dia EV por 7 dias
4. Omeprazol 20 mg al dia VO por 7 dias
5. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8 hrs VO SOS por 7 dias
6. KNT motora dos veces al dia
7. Examenes de control 03/05

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO